

AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 13 · UR · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM · UROLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

38	13	3
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · complemento visual del Tomo 13

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 13 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 23

Índice por tipo de imagen 26

Soluciones de la autoevaluación 28

Signos con nombre propio 25

Autoevaluación 27

01 Urolitiasis & Obstrucción Urinaria

13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria

01 Cálculos renales bilaterales en la TAC 4

02 Hidronefrosis 4

03 Cálculo en la Rx simple 5

04 Nefrostomía percutánea 5

13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria

05 Gran residuo postmiccional 6

06 Estenosis de la uretra bulbar 6

07 Rotura uretral 7

13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)

08 Lóbulos prostáticos que cierran la uretra 7

09 Vejiga trabeculada 8

10 Lóbulo medio prostático 8

02 Urgencias Urológicas & Escroto Agudo

13.5 Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide

11 Testículo normal y en badajo de campana 9

12 Signo de Gouverneur 9

13 Torsión testicular en el Doppler 10

13.6 Orquiepididimitis Aguda

14 Epididimitis 10

15 Uretritis gonocócica 11

13.7 Patología Escrotal No Dolorosa

16 Varicocele izquierdo 11

17 Hidrocele derecho 12

18 Quiste de epidídimo 12

19 Quiste de epidídimo en la cabeza 13

20 Hidrocele: escroto aumentado 13

03 Uro-Oncología

13.8 Cáncer de Próstata

21 Ecografía transrectal normal 14

22 RM multiparamétrica de próstata 14

23 Cilindros de biopsia prostática 15

13.9 Cáncer de Próstata

24 Cintigrama óseo con metástasis 15

13.10 Cáncer de Testículo

25 Tumor testicular 16

26 Adenopatías retroperitoneales 16

27 Metástasis en bala de cañón 17

28 Metástasis pulmonares en la TAC 17

13.11 Cáncer Renal

29 Masa renal que realza 18

30 Angiomiolipoma 18

31 Pieza de nefrectomía radical 19

13.12 Cáncer de Vejiga

32 Tumor vesical papilar 19

33 Cáncer vesical que invade la pared 20

04 Infecciones Urológicas, Quistes & Hematuria

13.14 Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

34 Quiste renal simple 20

35 Riñón poliquístico 21

36 Poliquistosis renal en la TAC 21

Índice por tema · continuación

13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria

37 Hematíes dismórficos 22

38 Cilindro hemático 22

01 TEMA 13.1 · CÓLICO RENAL Y LITIASIS URINARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

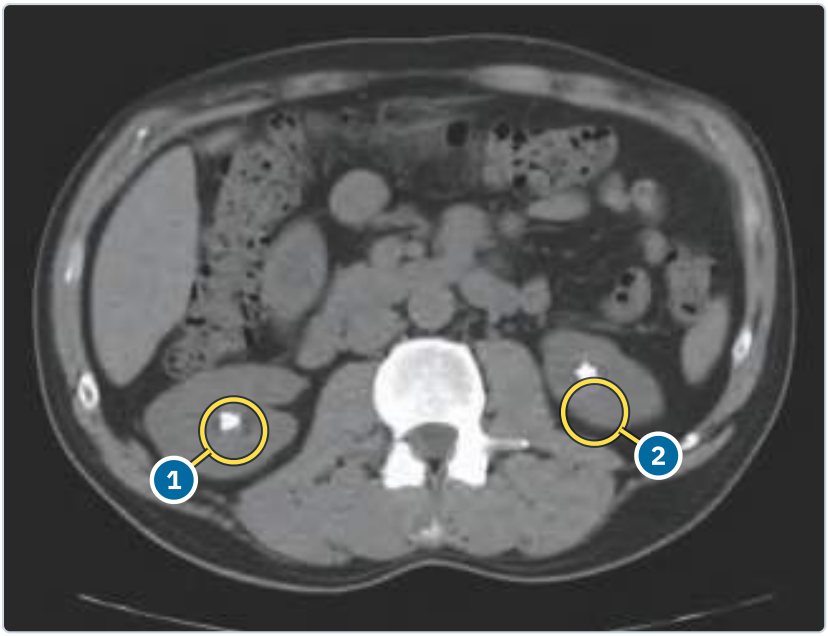


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.21a

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cálculo
2. Cálculo

DIAGNÓSTICO

Cálculos renales bilaterales en la TAC

Imágenes muy densas en ambos riñones.

CONDUCTA INICIAL

PieloTAC sin contraste: examen de elección en el cólico renal.

4.03.4.003	Pielo TAC	examen/procedimiento
4.03.1.025	Urolitiasis	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Flebolitos: en la pelvis, con centro claro.

PREGUNTA REAL — **Julio 2025 · P90** «Hombre de 45 años con dolor lumbar derecho irradiado a la región inguinal, tipo cólico, de inicio súbito. Uroanálisis: microhematuria, sin…» → **UroTAC (PieloTAC sin contraste)**

TOMO UROLOGÍA **p. 8** Tema 13.1

Clase 13.1 en video

02 TEMA 13.1 · CÓLICO RENAL Y LITIASIS URINARIA

ECOGRAFÍA

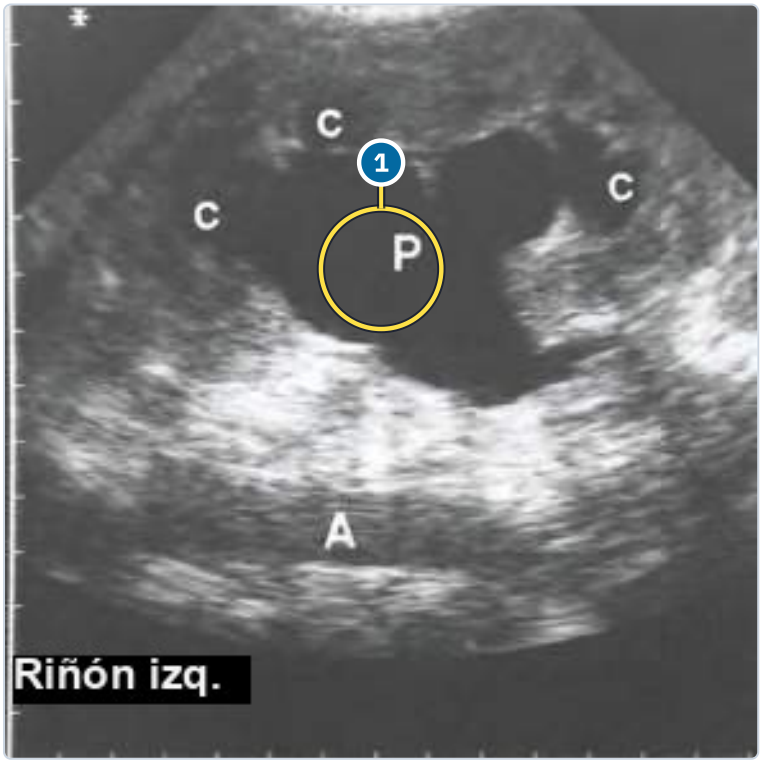


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 76.15

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pelvis dilatada

DIAGNÓSTICO

Hidronefrosis

Pelvis (P) y cálices (C) dilatados.

CONDUCTA INICIAL

Obstrucción + fiebre: desobstruir urgente (pigtail o nefrostomía).

4.03.1.012	Hidronefrosis	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.03.2.001	Cólico renal	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pelvis extrarrenal: sin cálices dilatados.

PREGUNTA REAL — **Julio 2019 · P74** «Un paciente de 18 años consulta por dolor lumbar izquierdo, de larga evolución. Al examen físico tiene una masa en el flanco izquierdo, por lo…» → **Realizar nefrectomía izquierda**

TOMO UROLOGÍA **p. 8** Tema 13.1

Clase 13.1 en video

03 TEMA 13.1 · CÓLICO RENAL Y LITIASIS URINARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.20a

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cálculo

DIAGNÓSTICO

Cálculo en la Rx simple

Opacidad sobre el trayecto urinario.

CONDUCTA INICIAL

Menor de 5 mm: expulsión espontánea con tamsulosina y analgesia.

4.03.4.001	Radiografía renal y vesical simple	examen/procedimiento
4.03.2.001	Cólico renal	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ácido úrico: radiolúcido.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P33** «Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección…» → **PieloTAC**

TOMO UROLOGÍA **p. 8** Tema 13.1

Clase 13.1 en video

04 TEMA 13.1 · CÓLICO RENAL Y LITIASIS URINARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

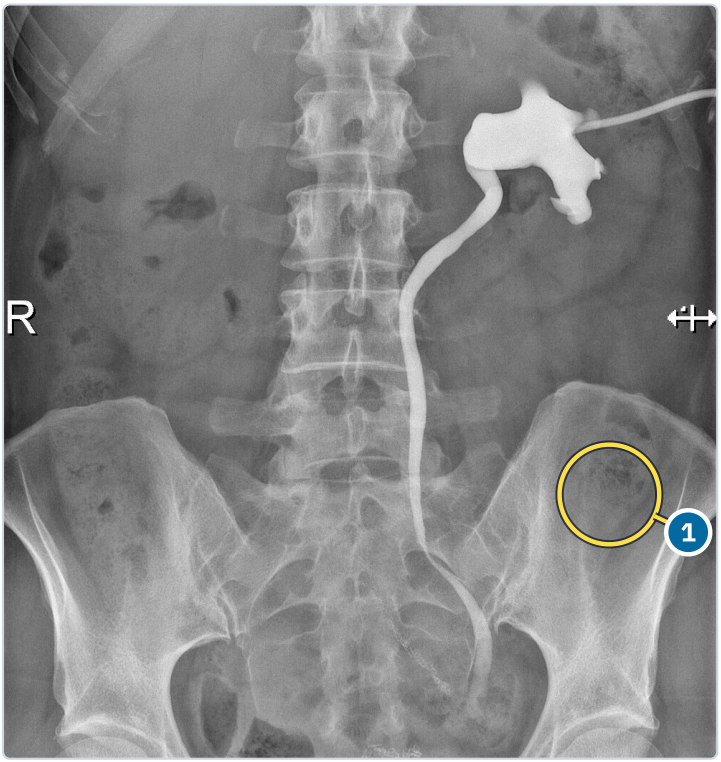


Imagen: Wikimedia Commons «Nephrostomy, case 1, X-ray 2.jpg», CC BY-SA 3.0, Jmarchn

QUÉ TIENES QUE VER

1 Guía en la pelvis renal

DIAGNÓSTICO

Nefrostomía percutánea

Hidronefrosis drenada con guía percutánea.

CONDUCTA INICIAL

Uropatía obstructiva infectada: drenaje urgente.

1.09.5.005	Nefrostomia percutánea	examen/procedimiento
4.03.1.012	Hidronefrosis	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Catéter doble J: por vía endoscópica.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 8** Tema 13.1

Clase 13.1 en video

05 TEMA 13.2 · UROPATÍA OBSTRUCTIVA AGUDA Y RETENCIÓN URINARIA

ECOGRAFÍA

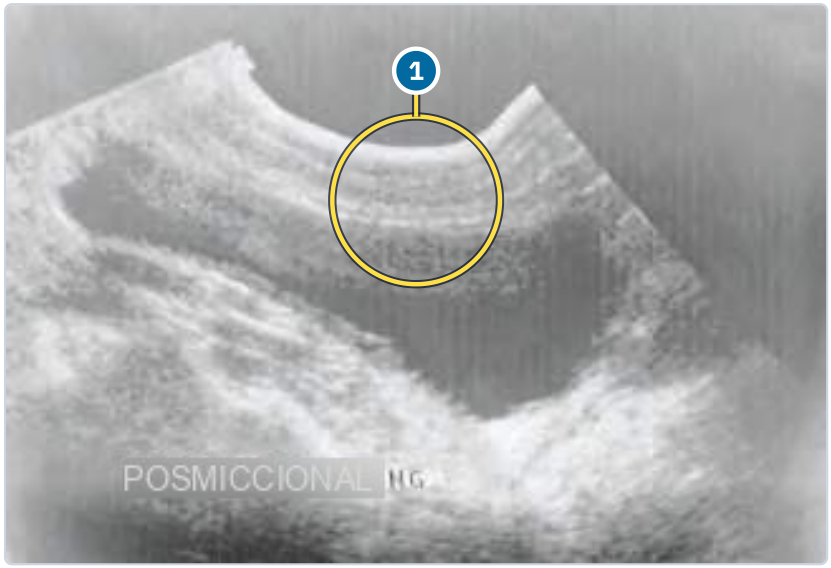


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 78.9

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vejiga distendida

DIAGNÓSTICO

Gran residuo postmiccional

Vejiga llena después de orinar.

CONDUCTA INICIAL

Retención: sonda Foley.

4.03.2.006	Retención urinaria aguda — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar
4.03.1.027	Uropatía obstructiva baja — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ascitis: líquido fuera de la vejiga.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P19** «Hombre de 70 años con HPB conocida llega a urgencias con incapacidad de orinar desde hace 8 horas, vejiga palpable en hipogastrio y dolor…» → **Sonda Foley vesical**

TOMO UROLOGÍA p. 13 Tema 13.2

Clase 13.2 en video

06 TEMA 13.2 · UROPATÍA OBSTRUCTIVA AGUDA Y RETENCIÓN URINARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

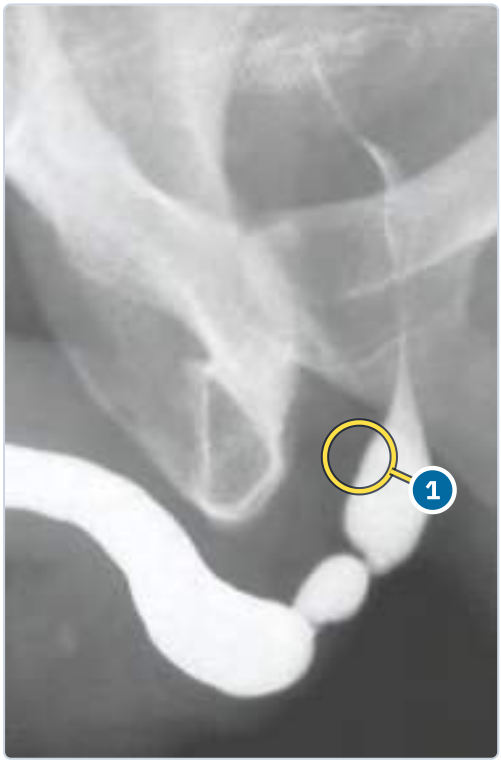


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 79.9

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estenosis

DIAGNÓSTICO

Estenosis de la uretra bulbar

Estrechez en la uretrografía ascendente.

CONDUCTA INICIAL

Uretrotomía o uretroplastía.

4.03.1.008	Estenosis uretral — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.03.4.005	Uretrocistografía — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Espasmo: se resuelve.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P55** «Un paciente masculino, de 30 años, consulta por diminución del calibre miccional, asociada a disuria de esfuerzo de varios meses de evolución….» → **Estenosis uretral**

TOMO UROLOGÍA p. 13 Tema 13.2

Clase 13.2 en video

07 TEMA 13.2 · UROPATÍA OBSTRUCTIVA AGUDA Y RETENCIÓN URINARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

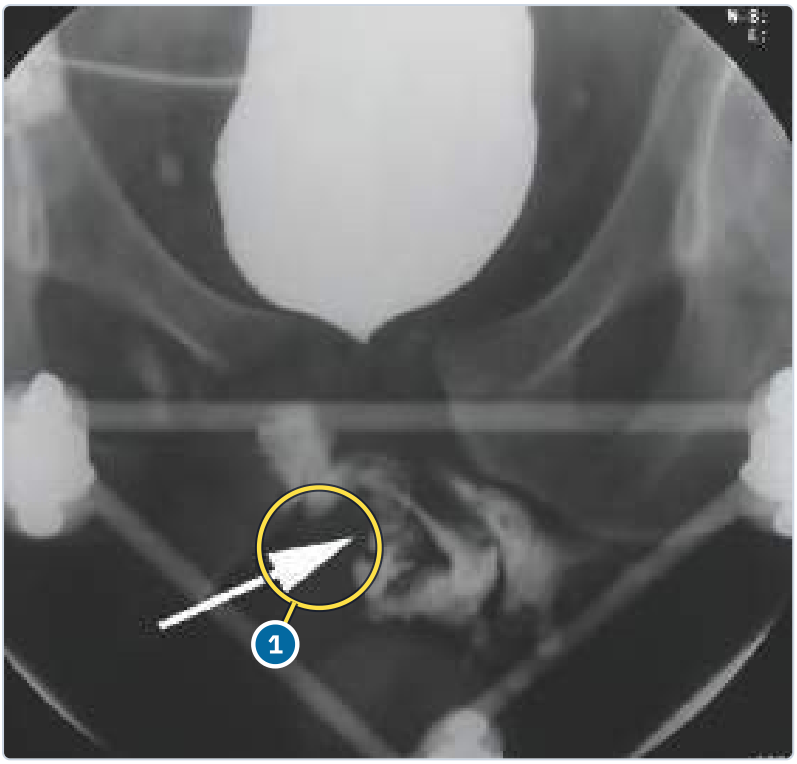


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 14.28

QUÉ TIENES QUE VER

1 Extravasación

DIAGNÓSTICO

Rotura uretral

Contraste fuera de la uretra (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Sangre en el meato tras fractura de pelvis: no sondear, cistostomía.

4.03.4.005	Uretrocistografía — examen/procedimiento
4.03.5.004	Cistostomía por punción — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Rotura vesical extraperitoneal.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P142** «Paciente con RTU hace 10 años, sin micción hace 8 horas, sonda que no avanza más allá de uretra bulbar con uretrorragia, sin globo vesical. ¿Cuál…» → **Uretrografía retrógrada**

TOMO UROLOGÍA p. 13 Tema 13.2

Clase 13.2 en video

08 TEMA 13.3 · HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB)

ENDOSCOPÍA

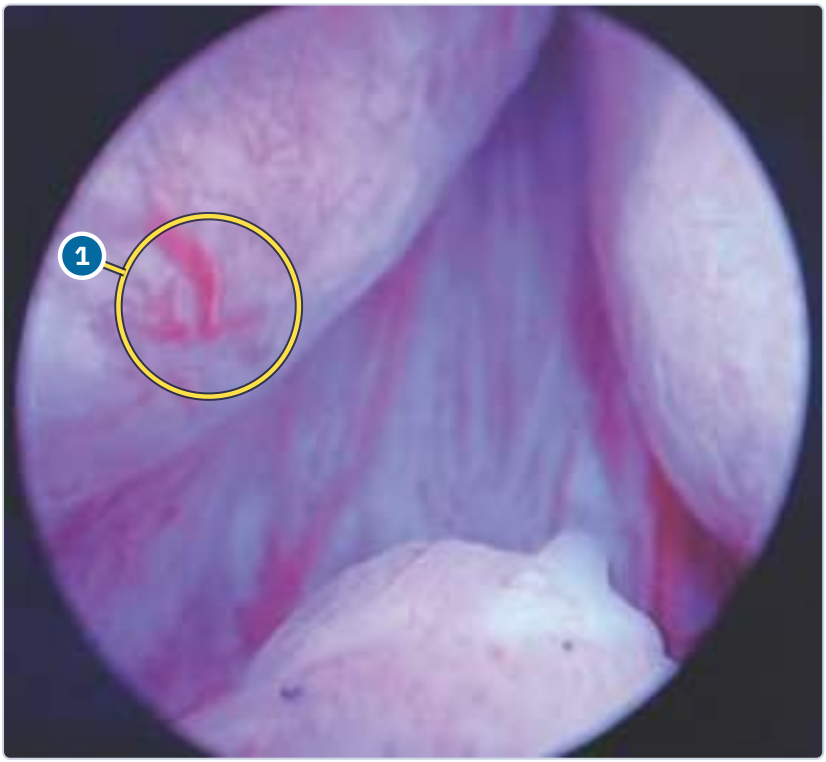


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.10

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lóbulos laterales

DIAGNÓSTICO

Lóbulos prostáticos que cierran la uretra

Visión cistoscópica de la uretra prostática.

CONDUCTA INICIAL

HPB: tamsulosina; finasteride si próstata grande.

4.03.1.013	Hiperplasia prostática benigna — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Estenosis uretral.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P104** «Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina…» → **Realizar prostatectomía vía resección transuretral**

TOMO UROLOGÍA p. 16 Tema 13.3

Clase 13.3 en video

09 TEMA 13.3 · HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB)

ENDOSCOPÍA

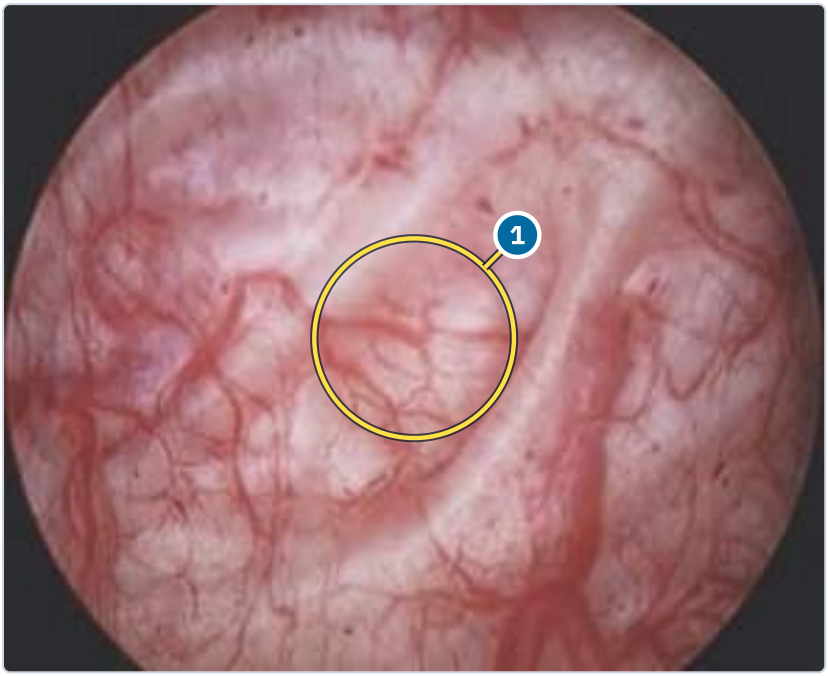


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.9

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trabéculas

DIAGNÓSTICO

Vejiga trabeculada

Pared con trabéculas por obstrucción crónica.

CONDUCTA INICIAL

Obstrucción prolongada: RTUP.

4.03.1.013 Hiperplasia prostática benigna — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

4.03.1.027 Uropatía obstructiva baja — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cistitis: mucosa roja sin trabéculas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA p. 16 Tema 13.3

Clase 13.3 en video

10 TEMA 13.3 · HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB)

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 1482

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lóbulo medio

DIAGNÓSTICO

Lóbulo medio prostático

Protruye dentro de la vejiga en la RM sagital.

CONDUCTA INICIAL

Responde menos a fármacos.

4.03.1.013 Hiperplasia prostática benigna — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tumor vesical.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA p. 16 Tema 13.3

Clase 13.3 en video

11 TEMA 13.5 · TORSIÓN TESTICULAR VS TORSIÓN DE HIDÁTIDE

ESQUEMA

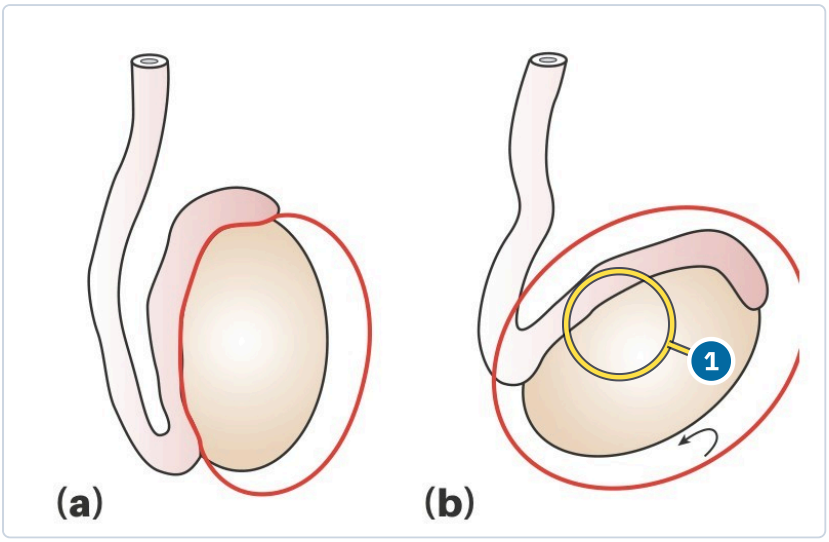


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Badajo

DIAGNÓSTICO

Testículo normal y en badajo de campana

El testículo horizontal puede rotar.

CONDUCTA INICIAL

Torsión: cirugía antes de 6 h.

4.03.2.007 Torsión testicular — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Normal: fijo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA p. 27 Tema 13.5

Clase 13.5 en video

12 TEMA 13.5 · TORSIÓN TESTICULAR VS TORSIÓN DE HIDÁTIDE

FOTO CLÍNICA

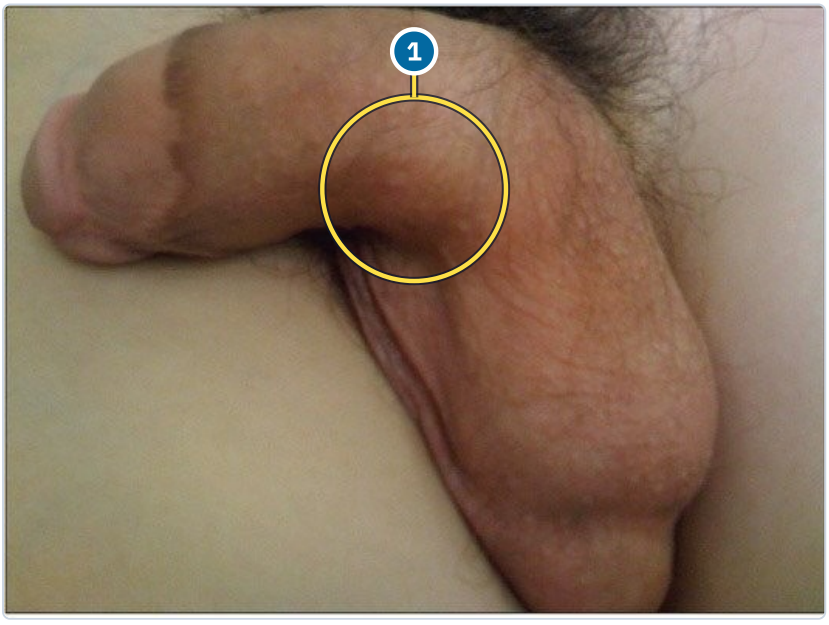


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 419

QUÉ TIENES QUE VER

1 Testículo alto

DIAGNÓSTICO

Signo de Gouverneur

Testículo ascendido y horizontal.

CONDUCTA INICIAL

Exploración quirúrgica urgente sin esperar el Doppler.

4.03.2.007 Torsión testicular — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.2.025 Testículo agudo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Orquiepididimitis: Prehn positivo.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P44** «Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho…» → **Torsión testicular**

TOMO UROLOGÍA p. 26 Tema 13.5

Clase 13.5 en video

13 TEMA 13.5 · TORSIÓN TESTICULAR VS TORSIÓN DE HIDÁTIDE

ECOGRAFÍA

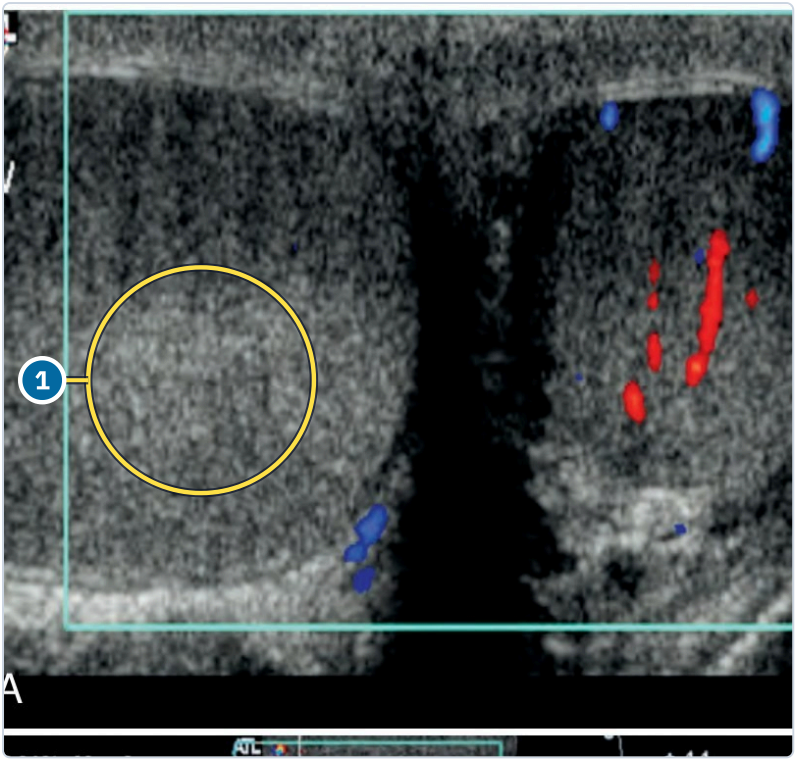


Imagen: Rumack, Diagnostic Ultrasound, 4.ª ed., p. 1966

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sin flujo

DIAGNÓSTICO

Torsión testicular en el Doppler

El testículo afectado no tiene flujo.

CONDUCTA INICIAL

Destorsión y orquidopexia bilateral.

4.03.2.007	Torsión testicular	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.03.4.008	Ecotomografía testicular	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Orquitis: flujo aumentado.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 27** Tema 13.5

Clase 13.5 en video

14 TEMA 13.6 · ORQUIEPIDIDIMITIS AGUDA

ECOGRAFÍA

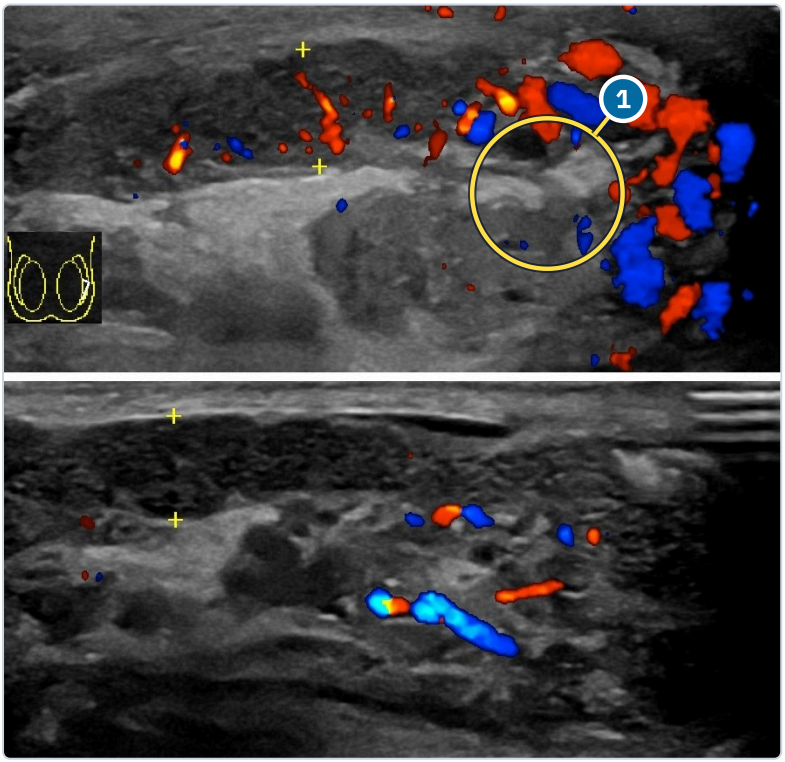


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Epidídimo hipervascular

DIAGNÓSTICO

Epididimitis

Epidídimo engrosado e hipervascular.

CONDUCTA INICIAL

Menor de 35: ceftriaxona + doxiciclina; mayor: quinolona.

4.03.1.007	Epididimitis	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Torsión: sin flujo.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2019 · P179** «Un paciente de 60 años fue tratado hace 7 días con ciprofloxacino, por disuria. Hace dos días presenta dolor testicular izquierdo, asociado a…» → **Orquiepididimitis**

TOMO UROLOGÍA **p. 32** Tema 13.6

Clase 13.6 en video

15 TEMA 13.6 · ORQUIEPIDIDIMITIS AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 1602 (Fig. 163.4)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Secreción

DIAGNÓSTICO

Uretritis gonocócica

Secreción purulenta por el meato.

CONDUCTA INICIAL

Ceftriaxona + azitromicina o doxiciclina; tratar la pareja.

4.03.1.006 Enfermedades de transmisión sexual
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Uretritis no gonocócica: secreción escasa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 32** Tema 13.6

Clase 13.6 en video

16 TEMA 13.7 · PATOLOGÍA ESCROTAL NO DOLOROSA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4260

QUÉ TIENES QUE VER

1 Varicocele

DIAGNÓSTICO

Varicocele izquierdo

Bolsa de gusanos sobre el testículo.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía si duele, hay atrofia o infertilidad.

4.03.1.028 Varicocele
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hidrocele: transilumina.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P148** «Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen perotesticular,…» → **Realizar varicosectomía**

TOMO UROLOGÍA **p. 35** Tema 13.7

Clase 13.7 en video

17 TEMA 13.7 · PATOLOGÍA ESCROTAL NO DOLOROSA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.10

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hidrocele

DIAGNÓSTICO

Hidrocele derecho

Aumento de volumen escrotal liso.

CONDUCTA INICIAL

Ecografía para descartar tumor.

4.03.1.011 Hidrocele

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hernia inguinoescrotal: no transilumina.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO UROLOGÍA **p. 35** Tema 13.7

Clase 13.7 en video

18 TEMA 13.7 · PATOLOGÍA ESCROTAL NO DOLOROSA

ECOGRAFÍA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.13

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste de epidídimo

Lesión anecoica separada del testículo.

CONDUCTA INICIAL

Observación.

4.03.1.020 Quistes del epidídimo

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tumor testicular: sólido.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P82 «Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba futbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico…» → **Observación**

TOMO UROLOGÍA **p. 35** Tema 13.7

Clase 13.7 en video

19 TEMA 13.7 · PATOLOGÍA ESCROTAL NO DOLOROSA

ECOGRAFÍA

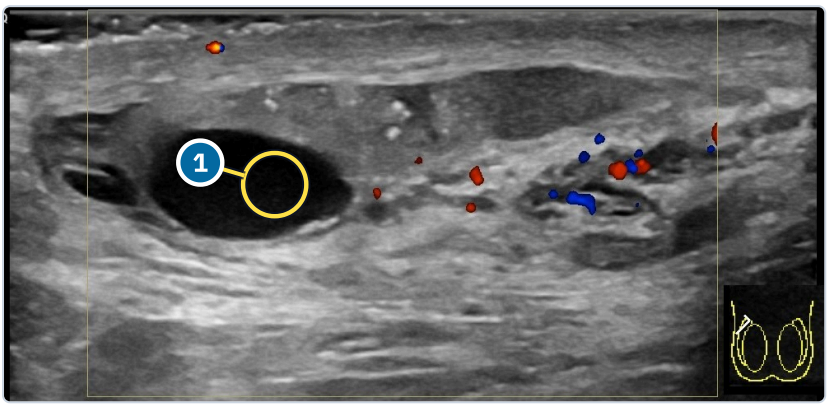


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste de epidídimo en la cabeza

Lesión anecoica bien definida.

CONDUCTA INICIAL

Benigno: no requiere cirugía.

4.03.1.020 Quistes del epidídimo

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hidrocele.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 35** Tema 13.7

Clase 13.7 en video

20 TEMA 13.7 · PATOLOGÍA ESCROTAL NO DOLOROSA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 405

QUÉ TIENES QUE VER

1 Escroto

DIAGNÓSTICO

Hidrocele: escroto aumentado

Transiluminación positiva.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía si es grande o molesto.

4.03.1.011 Hidrocele

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hernia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 35** Tema 13.7

Clase 13.7 en video

21 TEMA 13.8 · CÁNCER DE PRÓSTATA

ECOGRAFÍA

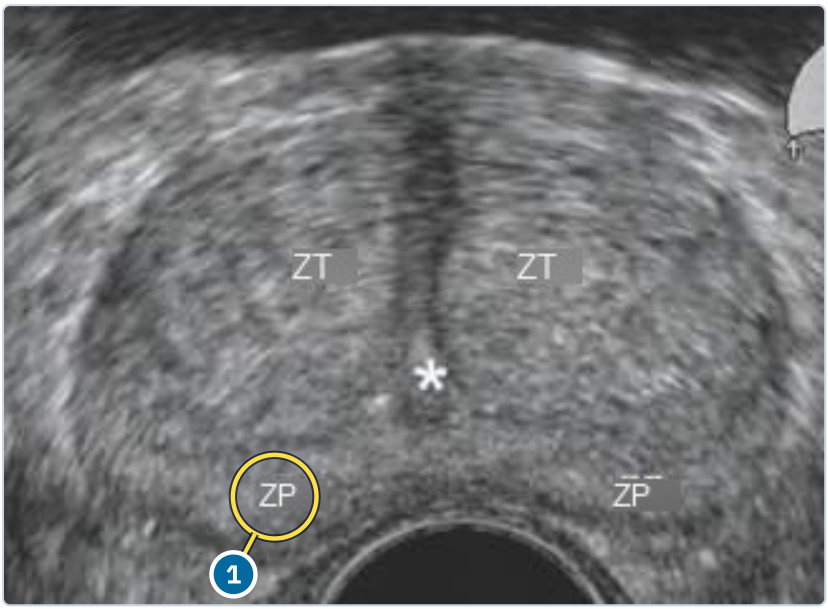


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.17a

QUÉ TIENES QUE VER

1 Zona periférica

DIAGNÓSTICO

Ecografía transrectal normal

Zona transicional (ZT) y periférica (ZP).

CONDUCTA INICIAL

Guía la biopsia.

4.03.5.001 **Biopsia prostática** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

El cáncer nace en la zona periférica.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 48** Tema 13.8

Clase 13.8 en video

22 TEMA 13.8 · CÁNCER DE PRÓSTATA

IMAGEN RADIOLÓGICA

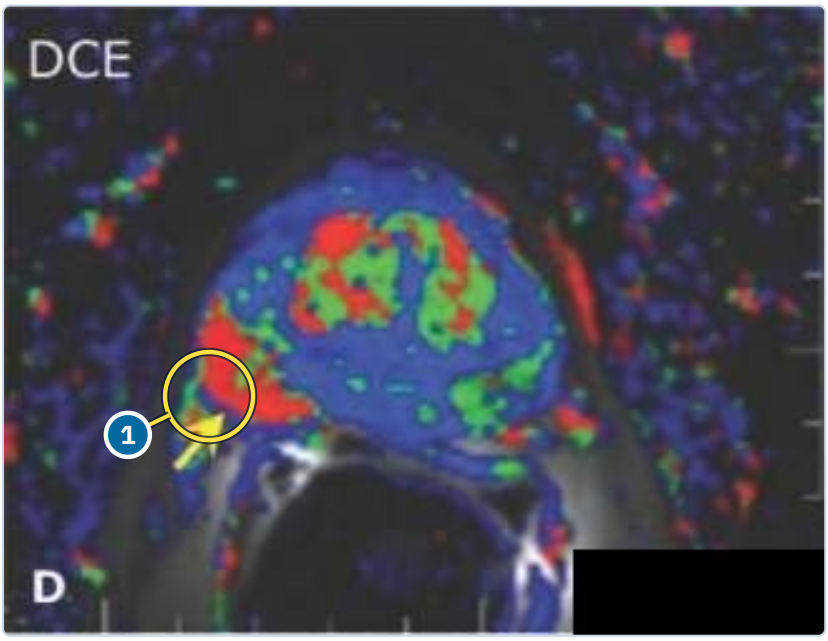


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 1413

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesión

DIAGNÓSTICO

RM multiparamétrica de próstata

Lesión sospechosa en la zona periférica (flecha).

CONDUCTA INICIAL

PI-RADS 4–5: biopsia dirigida.

4.03.1.002 **Cáncer de próstata** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.03.5.001 **Biopsia prostática** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Prostatitis.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P41** «Un paciente de 85 años presenta APE de 7,5 ng/ml. Está asintomático y no tiene an- tecedente de infecciones urinarias. Su tacto rectal demuestra…» → **Realizar biopsia prostática**

TOMO UROLOGÍA **p. 48** Tema 13.8

Clase 13.8 en video

23 TEMA 13.8 · CÁNCER DE PRÓSTATA

PIEZA ANATÓMICA

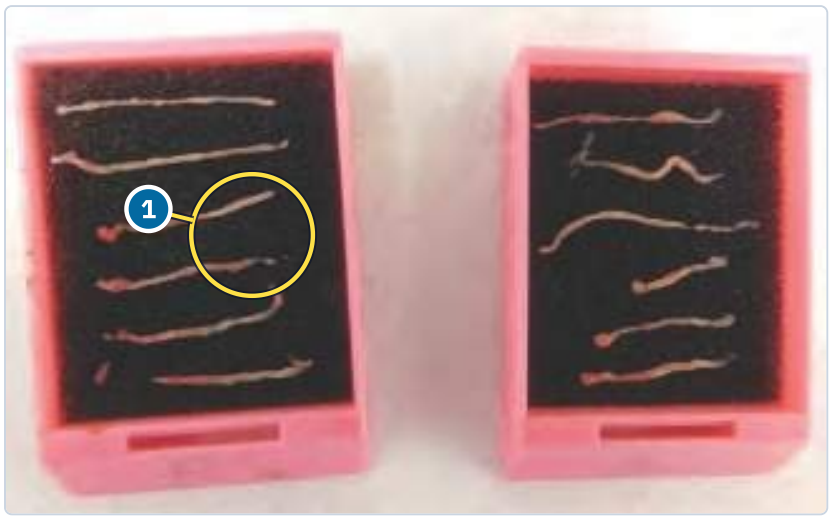


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.18b

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cilindros

DIAGNÓSTICO

Cilindros de biopsia prostática

Muestras por lóbulo.

CONDUCTA INICIAL

Gleason define el riesgo.

4.03.5.001 **Biopsia prostática**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Biopsia insuficiente.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 48** Tema 13.8

Clase 13.8 en video

24 TEMA 13.9 · CÁNCER DE PRÓSTATA

IMAGEN RADIOLÓGICA

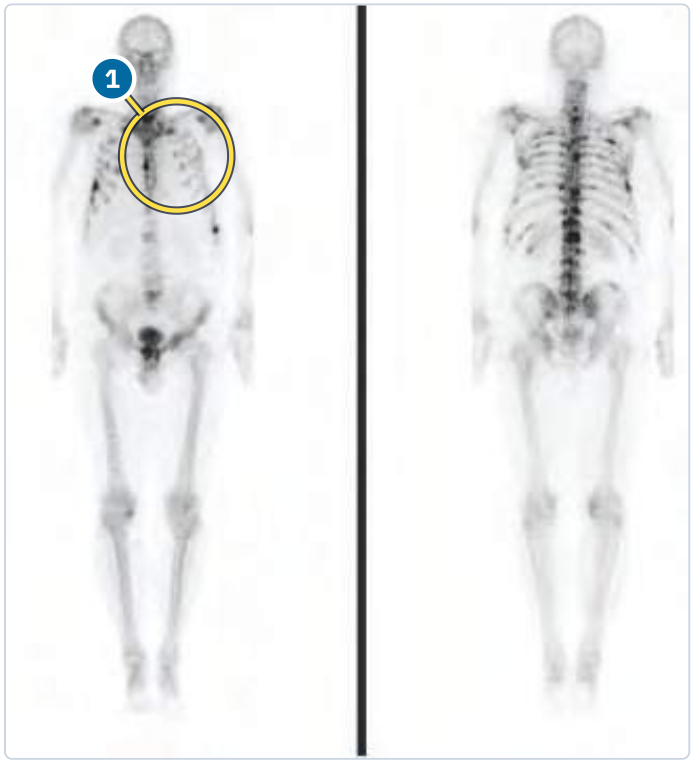


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.27b

QUÉ TIENES QUE VER

1 Focos en la columna

DIAGNÓSTICO

Cintigrama óseo con metástasis

Múltiples focos en columna, costillas y pelvis.

CONDUCTA INICIAL

Alto volumen: hormonoterapia más quimioterapia o nuevos antiandrógenos.

4.03.1.002 **Cáncer de próstata**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.4.002 **Cintigrafía ósea y cintigrafía con galio**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Artrosis: captación articular.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P103** «Paciente de 83 años con APE 10, adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 en 0,3% de la muestra, estudio de diseminación negativo. ¿Cuál es la…» → **Vigilancia activa con control en 3 meses**

TOMO UROLOGÍA **p. 53** Tema 13.9

Clase 13.9 en video

25 TEMA 13.10 · CÁNCER DE TESTÍCULO

ECOGRAFÍA

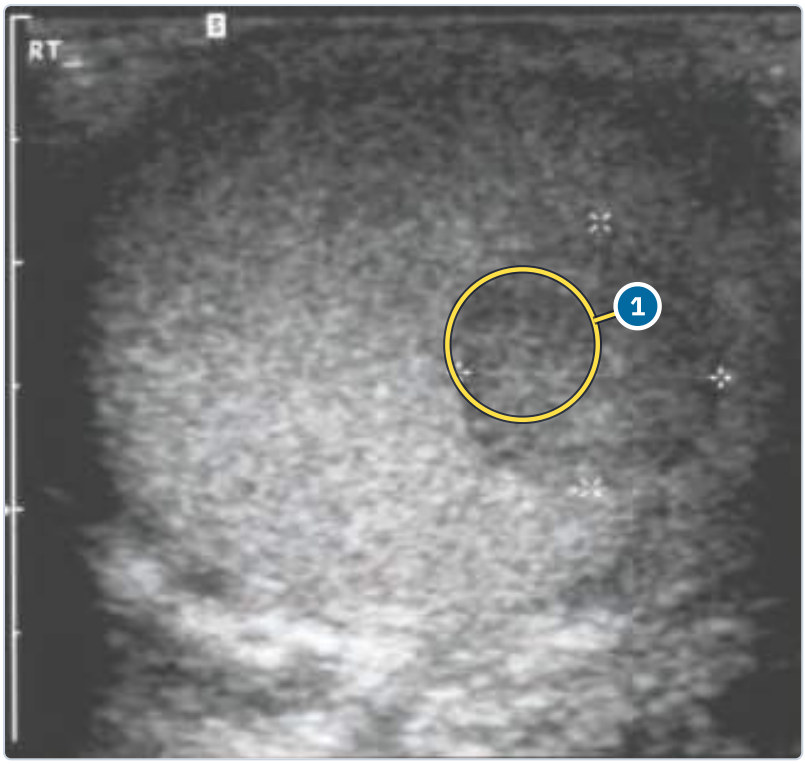


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.16

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo

DIAGNÓSTICO

Tumor testicular

Nódulo hipoecogénico.

CONDUCTA INICIAL

Marcadores y orquiectomía radical inguinal.

4.03.1.024	Tumor testicular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.03.4.008	Ecotomografía testicular	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Quiste: anecoico.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P162** «Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen escrotal derecho. Al exa- men físico se palpa un tumor en relación al testículo derecho....» → **Orquiectomía radical**

TOMO UROLOGÍA **p. 56** Tema 13.10

Clase 13.10 en video

26 TEMA 13.10 · CÁNCER DE TESTÍCULO

IMAGEN RADIOLÓGICA

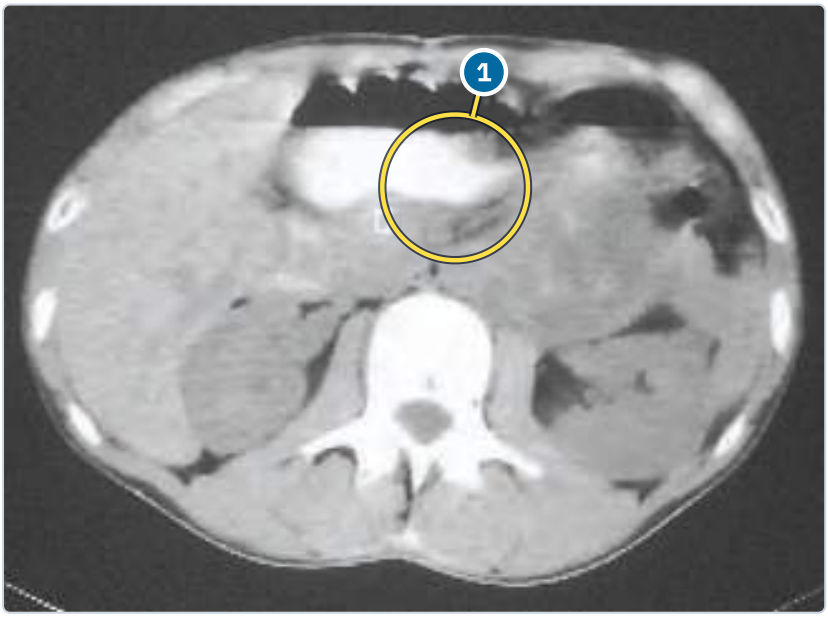


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.20

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa

DIAGNÓSTICO

Adenopatías retroperitoneales

Masa retroperitoneal por metástasis.

CONDUCTA INICIAL

Etapificación con TAC.

4.03.1.024	Tumor testicular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Aneurisma aórtico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 56** Tema 13.10

Clase 13.10 en video

27 TEMA 13.10 · CÁNCER DE TESTÍCULO

IMAGEN RADIOLÓGICA

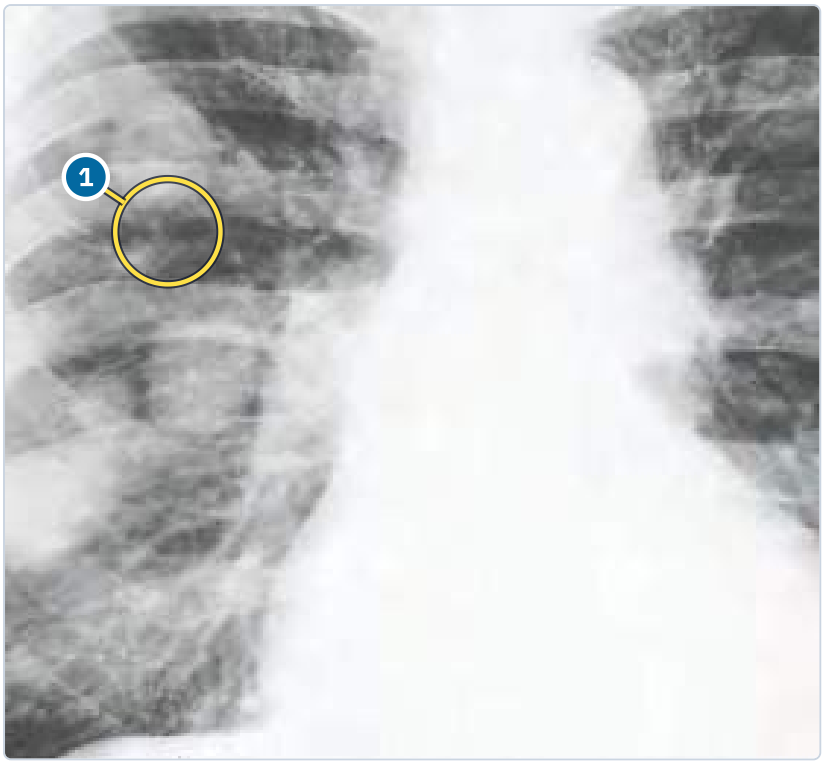


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.19

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo

DIAGNÓSTICO

Metástasis en bala de cañón

Nódulos pulmonares redondos.

CONDUCTA INICIAL

Quimioterapia: muy curable.

4.03.1.024 Tumor testicular — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Granulomas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 56** Tema 13.10

Clase 13.10 en video

28 TEMA 13.10 · CÁNCER DE TESTÍCULO

IMAGEN RADIOLÓGICA

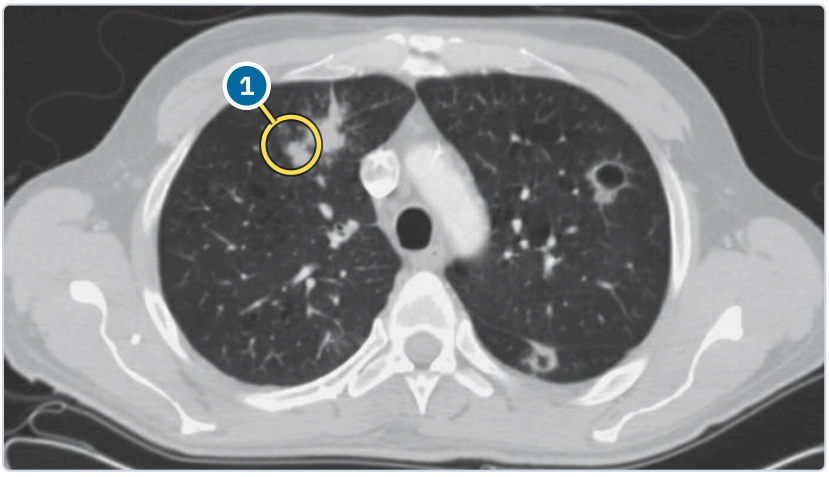


Imagen: CT and MRI Pathology, p. 249

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo

DIAGNÓSTICO

Metástasis pulmonares en la TAC

Nódulos múltiples.

CONDUCTA INICIAL

Tumor de células germinales: BEP.

4.03.1.024 Tumor testicular — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Embolia séptica: cavitada.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 58** Tema 13.10

Clase 13.10 en video

29 TEMA 13.11 · CÁNCER RENAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

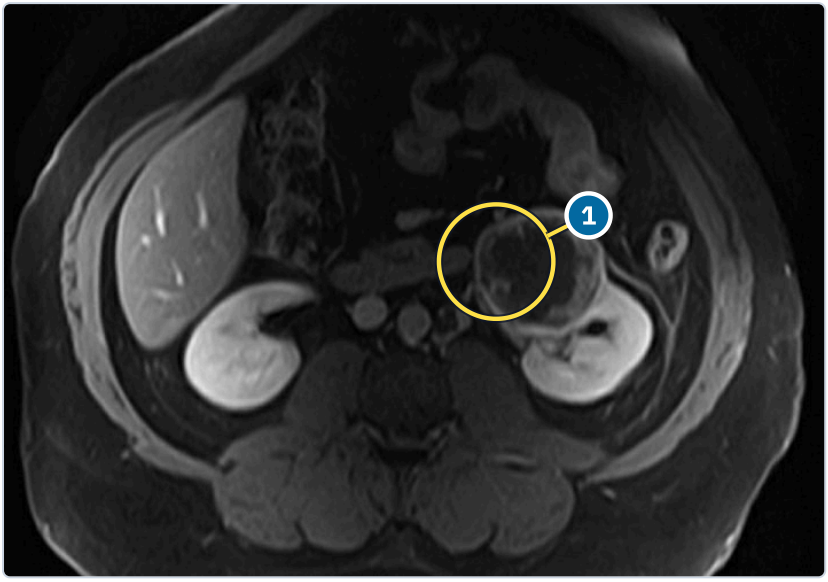


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 362

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa renal

DIAGNÓSTICO

Masa renal que realza

Masa sólida del riñón izquierdo.

CONDUCTA INICIAL

Nefrectomía parcial o radical.

4.03.1.022 **Tumor renal**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.03.4.004 **TAC de abdomen y pelvis**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Quiste: no realza.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P46** «Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido,…» → **Nefrectomía parcial**

TOMO UROLOGÍA **p. 61** Tema 13.11

Clase 13.11 en video

30 TEMA 13.11 · CÁNCER RENAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

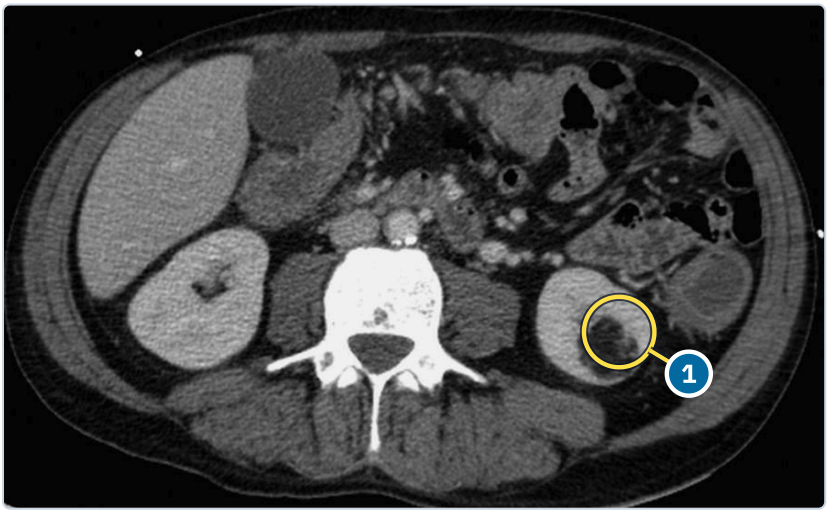


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 345

QUÉ TIENES QUE VER

1 Grasa

DIAGNÓSTICO

Angiomiolipoma

Masa con grasa macroscópica.

CONDUCTA INICIAL

Mayor de 4 cm: embolización.

4.03.1.022 **Tumor renal**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Carcinoma: sin grasa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 61** Tema 13.11

Clase 13.11 en video

31 TEMA 13.11 · CÁNCER RENAL

PIEZA ANATÓMICA

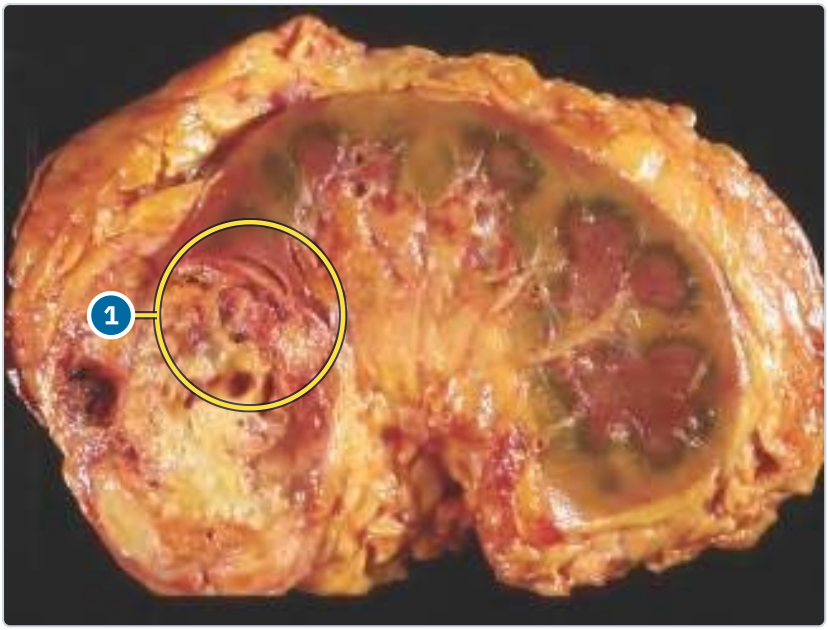


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 76.22

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tumor

DIAGNÓSTICO

Pieza de nefrectomía radical

Tumor amarillo de células claras.

CONDUCTA INICIAL

Seguimiento con TAC.

4.03.1.022	Tumor renal	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Oncocitoma: pardo con cicatriz central.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA p. 61 Tema 13.11

Clase 13.11 en video

32 TEMA 13.12 · CÁNCER DE VEJIGA

ENDOSCOPÍA

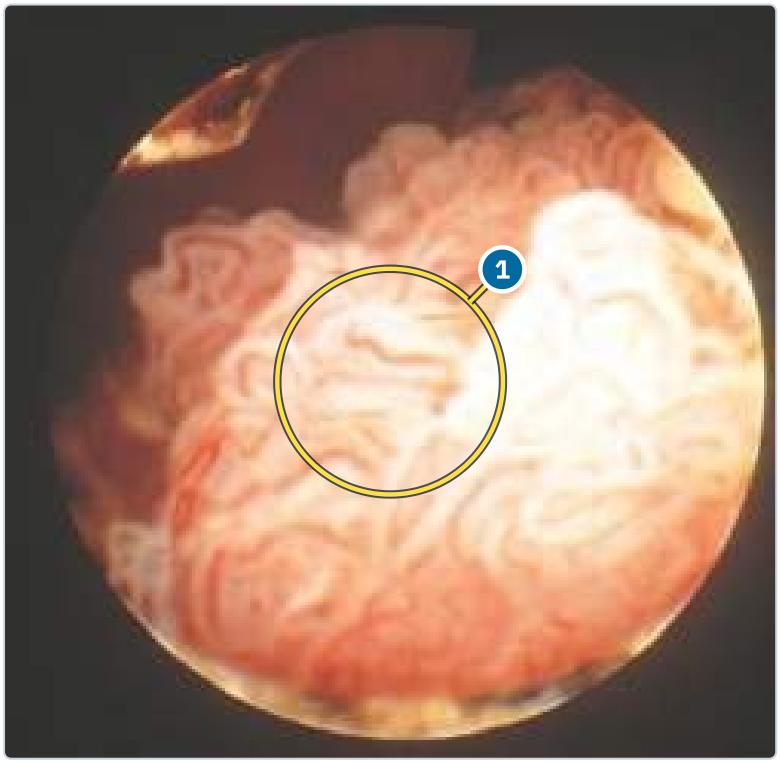


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 77.48

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tumor papilar

DIAGNÓSTICO

Tumor vesical papilar

Lesión papilar en la cistoscopía.

CONDUCTA INICIAL

RTUV y BCG según riesgo.

4.03.1.003	Cáncer de vejiga y urotelio	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.03.5.002	Cistoscopia	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cistitis.

PREGUNTA REAL — **Julio 2016 · P159** «Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros…» → **Cáncer de vejiga**

TOMO UROLOGÍA p. 65 Tema 13.12

Clase 13.12 en video

33 TEMA 13.12 · CÁNCER DE VEJIGA

IMAGEN RADIOLÓGICA

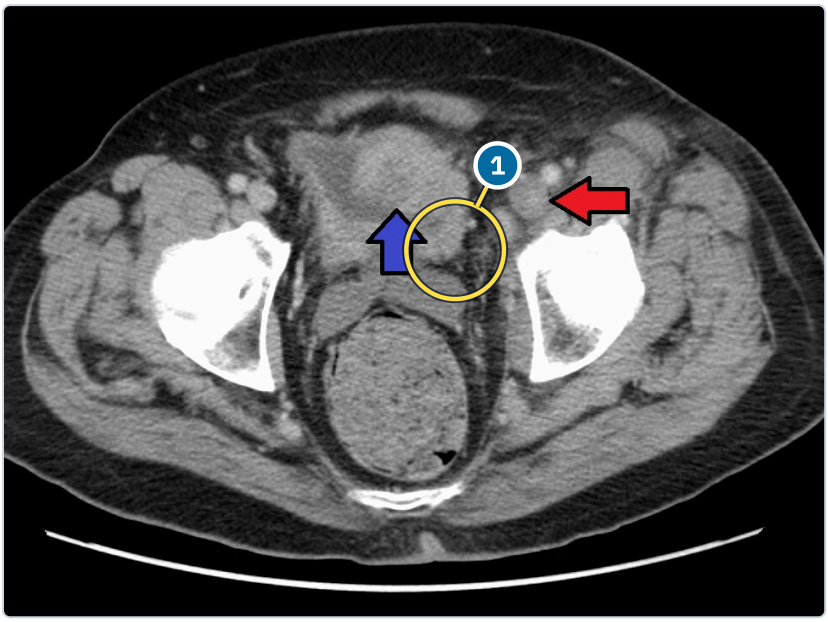


Imagen: Wikimedia Commons «BladderCADVTleftMark.png», CC BY-SA 4.0, James Heilman, MD

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa

DIAGNÓSTICO

Cáncer vesical que invade la pared

Masa que compromete la pared posterior.

CONDUCTA INICIAL

Infiltrante: cistectomía radical.

4.03.1.003 **Cáncer de vejiga y urotelio**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coágulo.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P85 «Una paciente de 54 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de disuria, polaquiuria y dolor abdominal bajo. Sus urocultivos repetidos…» → **Solicitar cistoscopía**

TOMO UROLOGÍA **p. 65** Tema 13.12

Clase 13.12 en video

34 TEMA 13.14 · QUISTES RENALES SIMPLES (BOSNIAK) & RIÑÓN POLIQUÍSTICO AUTOSÓMICO DOMINANTE

IMAGEN RADIOLÓGICA

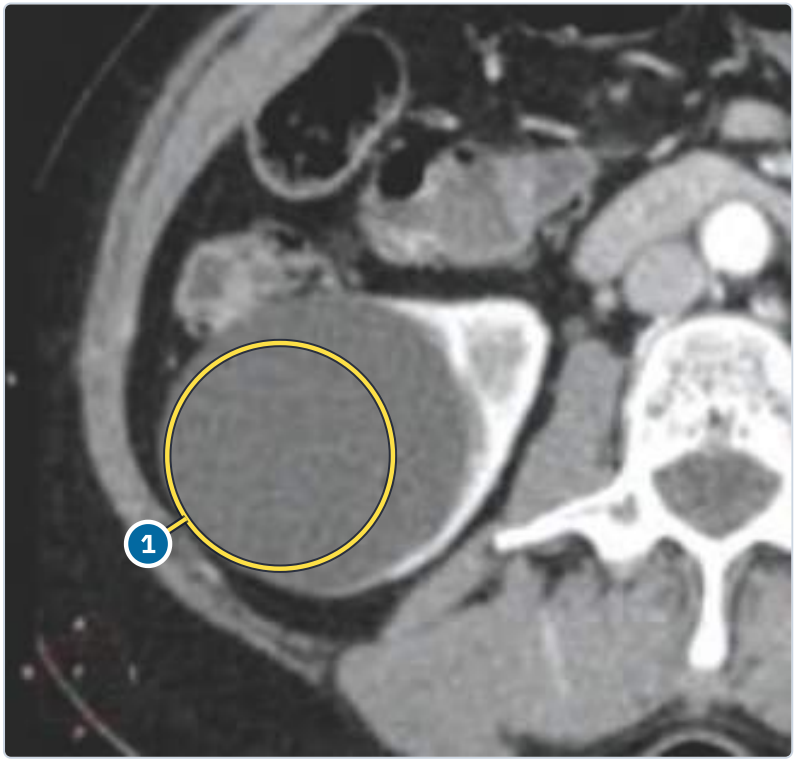


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.24 (panel de quiste simple)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste renal simple

Lesión homogénea sin pared.

CONDUCTA INICIAL

Bosniak I: sin seguimiento.

4.03.1.018 **Lesiones quísticas del riñón**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Bosniak III–IV: tabiques o realce.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO UROLOGÍA **p. 75** Tema 13.14

Clase 13.14 en video

35 TEMA 13.14 · QUISTES RENALES SIMPLES (BOSNIAK) & RIÑÓN POLIQUÍSTICO AUTOSÓMICO DOMINANTE

PIEZA ANATÓMICA

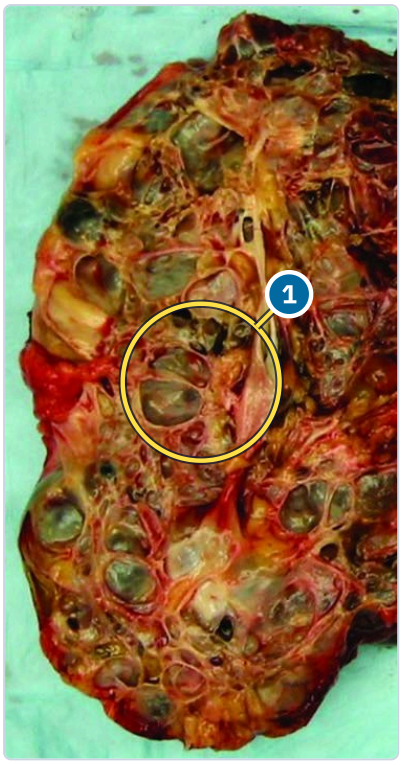


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 315-2

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quistes

DIAGNÓSTICO

Riñón poliquístico

Múltiples quistes.

CONDUCTA INICIAL

Controlar la presión; buscar aneurismas si hay historia familiar.

1.09.1.019 Riñón poliquístico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Quistes simples múltiples.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 75** Tema 13.14

Clase 13.14 en video

36 TEMA 13.14 · QUISTES RENALES SIMPLES (BOSNIAK) & RIÑÓN POLIQUÍSTICO AUTOSÓMICO DOMINANTE

IMAGEN RADIOLÓGICA

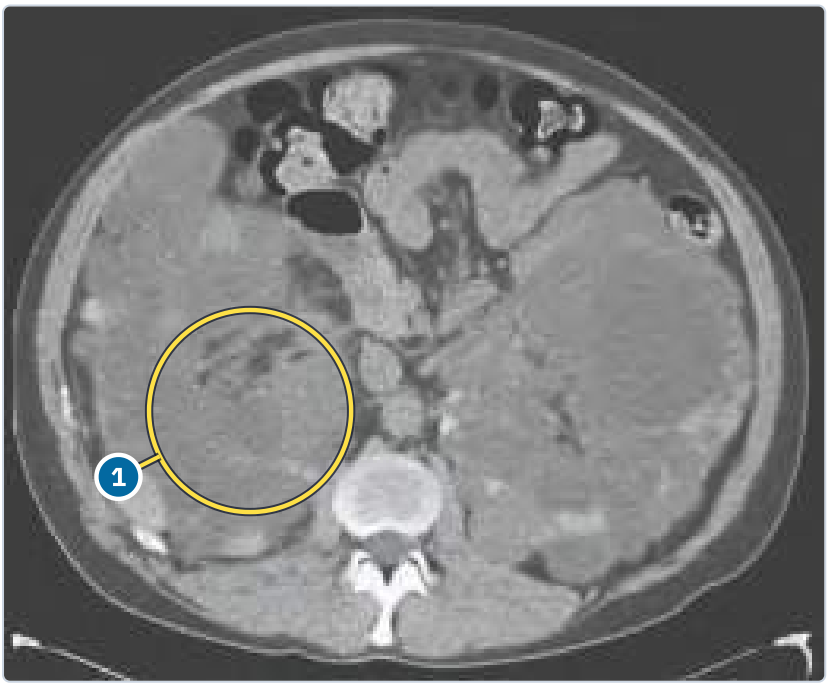


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 82.23

QUÉ TIENES QUE VER

1 Riñón

DIAGNÓSTICO

Poliquistosis renal en la TAC

Ambos riñones enormes.

CONDUCTA INICIAL

Tolvaptán en progresión rápida.

1.09.1.019 Riñón poliquístico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hidronefrosis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO UROLOGÍA **p. 75** Tema 13.14

Clase 13.14 en video

37 TEMA 13.15 · ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA HEMATURIA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 33

QUÉ TIENES QUE VER

1 Acantocito

DIAGNÓSTICO

Hematíes dismórficos

Origen glomerular de la hematuria.

CONDUCTA INICIAL

Glomerular: nefrología.

4.03.1.010 Hematuria — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.09.4.012 Examen de orina y sedimento urinario — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hematuria urológica: hematíes normales.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P100** «Un niño de 7 años se encuentra en el preoperatorio para una cirugía de fimosis. Se solicitan múltiples exámenes prequirúrgicos, entre los que se…» → **Repetir el examen de orina**

TOMO UROLOGÍA p. 79 Tema 13.15

Clase 13.15 en video

38 TEMA 13.15 · ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA HEMATURIA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Manual AMIR Nefrología 17.ª ed., p. 46

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cilindro

DIAGNÓSTICO

Cilindro hemático

Cilindro de glóbulos rojos.

CONDUCTA INICIAL

Síndrome nefrítico.

1.09.1.021 Síndrome nefrítico — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cilindro hialino.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P83** «Una paciente de 21 años, consulta por cuadro de algunos días de evolución de aste- nia, compromiso del estado general y disnea progresiva que…» → **Furosemida endovenosa**

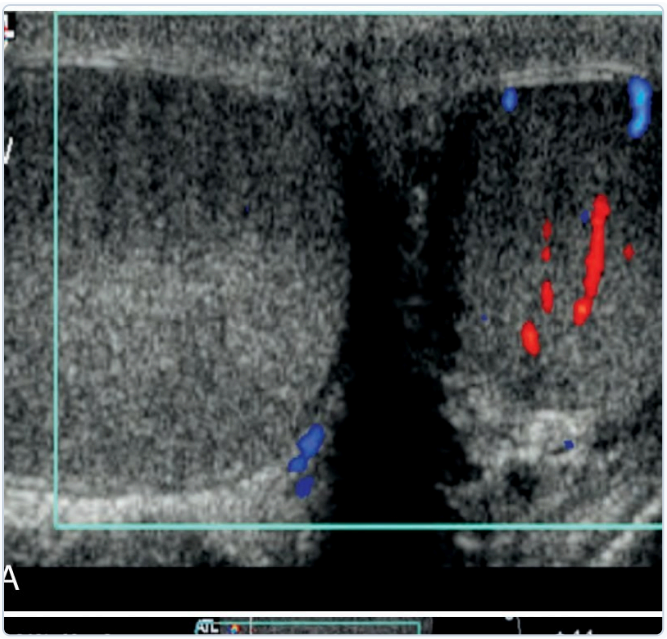
TOMO UROLOGÍA p. 79 Tema 13.15

Clase 13.15 en video

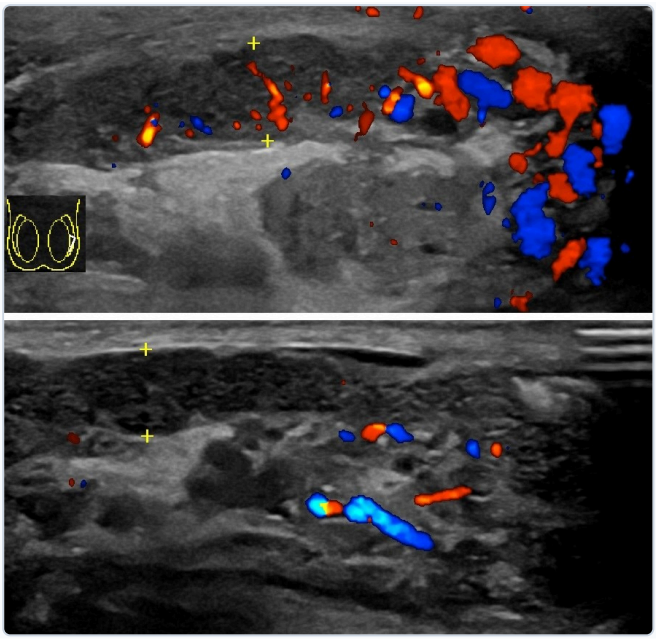
Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Torsión vs epididimitis



VS



A Torsión testicular en el Doppler

- Sin flujo

Ficha n.° 13 · p. 10

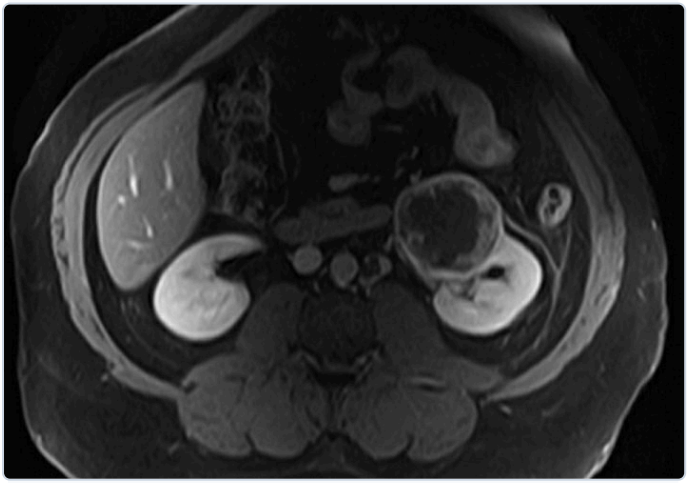
B Epididimitis

- Flujo aumentado

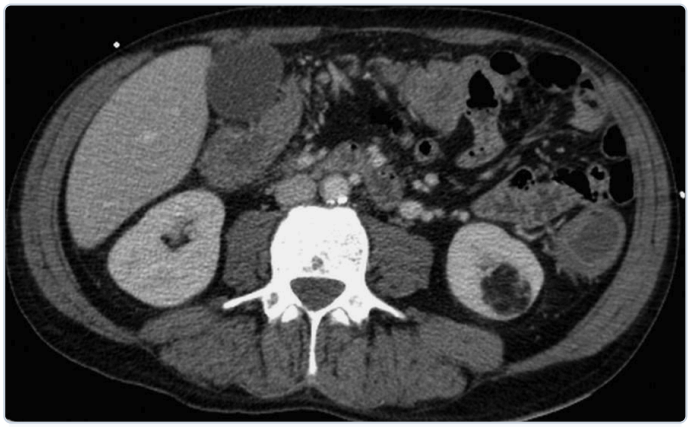
Ficha n.° 14 · p. 10

LA DIFERENCIA Ante duda: explorar.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Carcinoma vs angiomiolipoma



VS



A Masa renal que realza

- Sin grasa

Ficha n.° 29 · p. 18

B Angiomiolipoma

- Grasa macroscópica

Ficha n.° 30 · p. 18

LA DIFERENCIA La grasa define el angiomiolipoma.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Varicocele vs hidrocele



VS



A Varicocele izquierdo

- Bolsa de gusanos

Ficha n.° 16 · p. 11

B Hidrocele derecho

- Escroto liso que transilumina

Ficha n.° 17 · p. 12

LA DIFERENCIA El varicocele no transilumina.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



SIGNO DE GOUVERNEUR

Testículo ascendido y horizontal.

Se ve en: Torsión testicular.

Tomo p. 26 · Atlas: ficha n.° 12, p. 9



BOLSA DE GUSANOS

Venas dilatadas palpables sobre el testículo.

Se ve en: Varicocele.

Tomo p. 35 · Atlas: ficha n.° 16, p. 11

Índice por tipo de imagen

5	2	1	16	8	3
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	ECOGRAFÍA	ENDOSCOPÍA

3
PIEZA ANATÓMICA

Foto clínica · 5

12 Signo de Gouverneur (13.5) 9
15 Uretritis gonocócica (13.6) 11
16 Varicocele izquierdo (13.7) 11
17 Hidrocele derecho (13.7) 12
20 Hidrocele: escroto aumentado (13.7) 13

Histología / citología · 2

37 Hematíes dismórficos (13.15) 22
38 Cilindro hemático (13.15) 22

Esquema · 1

11 Testículo normal y en badajo de campana (13.5) 9

Imagen radiológica · 16

01 Cálculos renales bilaterales en la TAC (13.1) 4
03 Cálculo en la Rx simple (13.1) 5
04 Nefrostomía percutánea (13.1) 5
06 Estenosis de la uretra bulbar (13.2) 6
07 Rotura uretral (13.2) 7
10 Lóbulo medio prostático (13.3) 8
22 RM multiparamétrica de próstata (13.8) 14
24 Cintigrama óseo con metástasis (13.9) 15
26 Adenopatías retroperitoneales (13.10) 16
27 Metástasis en bala de cañón (13.10) 17
28 Metástasis pulmonares en la TAC (13.10) 17
29 Masa renal que realza (13.11) 18
30 Angiomiolipoma (13.11) 18
33 Cáncer vesical que invade la pared (13.12) 20
34 Quiste renal simple (13.14) 20
36 Poliquistosis renal en la TAC (13.14) 21

Ecografía · 8

02 Hidronefrosis (13.1) 4
05 Gran residuo postmiccional (13.2) 6
13 Torsión testicular en el Doppler (13.5) 10
14 Epididimitis (13.6) 10
18 Quiste de epidídimo (13.7) 12
19 Quiste de epidídimo en la cabeza (13.7) 13
21 Ecografía transrectal normal (13.8) 14
25 Tumor testicular (13.10) 16

Endoscopía · 3

08 Lóbulos prostáticos que cierran la uretra (13.3) 7
09 Vejiga trabeculada (13.3) 8
32 Tumor vesical papilar (13.12) 19

Pieza anatómica · 3

23 Cilindros de biopsia prostática (13.8) 15
31 Pieza de nefrectomía radical (13.11) 19
35 Riñón poliquístico (13.14) 21

Autoevaluación

4 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



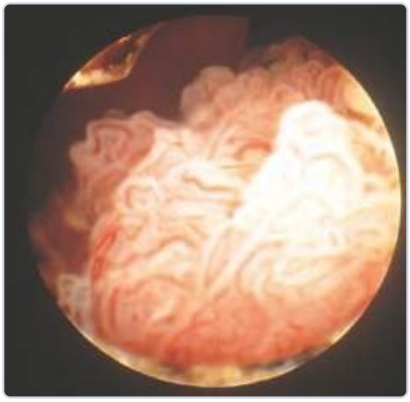
2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Signo de Gouverneur**	Testículo alto	12 · p. 9
2	**Varicocele izquierdo**	Varicocele	16 · p. 11
3	**Tumor testicular**	Nódulo	25 · p. 16
4	**Tumor vesical papilar**	Tumor papilar	32 · p. 19